Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Pelotas

Av. Ferreira Viana, 1134, 5º Andar - Sala 520 - Bairro: Areal - CEP: 96085000 - Fone: (53) 3026-8500 - Balcão Virtual : (53) 99953 - 1376 - Email: frpelotas1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5031680-84.2023.8.21.0022/RS

AUTOR: VANESSA OLIVEIRA DE AZAMBUJA

RÉU: UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos.

VANESSA OLIVEIRA DE AZAMBUJA, qualificada na exordial, ajuizou ação em desfavor de UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, igualmente qualificada, requerendo, liminarmente, a imediata disponibilização do exame Iodo Urinário de 24h e o fornecimento do medicamento Ferinject a ser administrado no próprio serviço da ré. No mérito, postulou a confirmação da decisão liminar.

Narrou, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde junto à ré. Discorreu estar no sexto mês de gestação e que, por recomendação da médica obstetra que lhe acompanha no pré-natal, necessitava de exame Iodo Urinário de 24h, bem como da medicação Ferinject. Disse que a ré não autorizou a realização do exame e o fornecimento da medicação.

Com a inicial, juntou documentos.

Deferido o benefício da gratuidade de justiça, concedida a tutela antecipada pleiteada e invertido o ônus probatório.

Citada, a ré UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, ofereceu contestação. Disse que, com relação ao exame pleiteado pela parte autora, este não consta elencado dentre os procedimentos de cobertura obrigatória previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Quanto ao fármaco, afirmou que não há cobertura assistencial ao fornecimento de medicamentos para uso doméstico. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio réplica.

Instadas as partes acerca do interesse na produção de provas, nada foi requerido.

Noticiado o descumprimento da decisão liminar, foi determinada a intimação pessoal da ré para o fornecimento do medicamento de forma imediata.

Os autos vieram conclusos para sentença.

Relatei. Passo a decidir.

A demanda comporta julgamento antecipado, uma vez que versa matéria exclusivamente de direito, os fatos pertinentes ao seu deslinde estão comprovados documentalmente (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I).

Postula a parte autora a disponibilização do exame Iodo Urinário de 24h e o fornecimento do medicamento Ferinject a ser administrado no próprio serviço da ré. Em suas razões, a parte ré alega que o exame postulado não consta elencado dentre os procedimentos de cobertura obrigatória previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, e que, quando ao fármaco, que não há cobertura assistencial ao fornecimento de medicamentos para uso doméstico.

Dessa forma, pende a controvérsia quanto à responsabilidade da ré pelo custeio do exame Iodo Urinário de 24h, bem como da medicação Ferinject.

De saída, cumpre destacar que nos planos ou seguros de saúde o Código de Defesa do Consumidor é aplicável, tendo em vista que se trata de relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Ademais, a Súmula nº. 608 do STJ sustenta: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Apresenta o Egrégio Tribunal de Justiça precedentes neste sentido:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REEMBOLSO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATERIAL NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO EXAME. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. 1. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica aos aderentes. 2. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem. 3. O plano de saúde não pode se recusar a custear exame indicado pelo médico, pois cabe a este definir o que é melhor para o segurado. Caso em que sequer há cláusula expressa no contrato de exclusão de cobertura do exame em tela, sendo devida a cobertura postulada. 4. Os contratantes devem observar o princípio da boa-fé em todas as fases do contrato. Inteligência do art. 422 do CC. 5. É devido o reembolso das despesas custeadas pelo autor, pois relativas ao tratamento, na forma da sentença.*

6. Danos morais. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa de atendimento não configura dano moral. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. 7. Honorários advocatícios devidos ao autor majorados para 12% sobre o valor da causa, já incluída a sucumbência recursal, tudo nos termos do art. 85, §§ 2° e 11, do CPC. APELO DA RÉ DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.(Apelação Cível, Nº 70080141179, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REEMBOLSO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LINFOMA DE HODGKIN. ADCETRIS (BRENTUXIMABE). PET/CT. REEMBOLSO. ASTREINTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A fixação da multa diária tem por finalidade a efetivação da tutela almejada, prestigiando o resultado prático do processo, ainda mais quando observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade e, jamais poderá importar em enriquecimento indevido da parte contrária. In casu, a parte apelante, ré, não traz justificativa condizente com o descumprimento, bem como as astreintes fixadas observam a razoabilidade. - A controvérsia objeto da lide - dever (ou não) de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento ou procedimento indicado pelo médico assistente - encontrava amplo espaço para divergência jurisprudencial em todos os âmbitos do Poder Judiciário, o que também refletia nos julgados proferidos pelo STJ. Entretanto, em recente julgado, a Seção competente ao julgamento da matéria, compreendida pela Terceira e Quarta Turmas do Tribunal da Cidadania, fixou teses sobre a matéria, dentre outras, indicando que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. - Contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o para o tratamento de câncer. - No caso dos autos, a autora é portadora de Linfoma de Hodgkin e o exame indicado pelo médico assistente - PET/CT - respeita a Diretriz de Utilização, conforme item 60, do Anexo II da RN nº 428/2017, ao que a cobertura é obrigatória. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50216592220228210010, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 28-03-2023)

Cumpre destacar que a função precípua da ANS é regulamentar os produtos e serviços no campo da saúde suplementar, respeitando as orientações previstas na Lei nº 9.565/1998. Acrescenta-se ainda que o artigo 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998 combinado com o artigo 4, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, atribui à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a competência legal de elaborar a lista de procedimentos e eventos que serão diretrizes básicas para embasar o disposto na Lei dos Planos de Saúde.

Convém destacar que, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento de que o rol da ANS, não é taxativo, mas sim exemplificativo, consoante pode-se observar do REsp Nº 1.876.630 - SP:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO INDICADO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA. DEVER DA OPERADORA DE INDENIZAR A USUÁRIA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DANO MORAL AFASTADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação indenizatória c/c compensação de dano moral ajuizada em 22/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/03/2020 e atribuído ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) o cerceamento de defesa; (ii) a obrigação de a operadora de plano de saúde indenizar a beneficiária pelas despesas com a realização de cirurgia, após recusar a cobertura do procedimento; (iii) a configuração e o valor arbitrado a título de compensação do dano moral. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência das provas demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na súmula 7/STJ, bem como que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória. 4. Nos termos do § 4º do art. 10 da Lei 9.656/1998, a amplitude da cobertura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, é regulamentada pela ANS, a quem compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas. 5. O Plenário do STF reafirmou, no julgamento da ADI 2.095/RS (julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), que "o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência", razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica. 6. Conquanto o art. 35-G da Lei 9.656/1998 imponha a aplicação subsidiária da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de plano de saúde, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes, considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional, orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza de adesão do contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com a edição da súmula 608 pelo STJ. 7. Quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais (art. 10, § 4º, da Lei 9.656/1998), não cabe ao órgão regulador, a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor, frustrando, assim, a própria finalidade do contrato. 8. O que se infere da leitura da Lei 9.656/1998 é que o plano-referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10, de modo que qualquer norma infralegal que a restrinja mostra-se abusiva e, portanto, ilegal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 9. O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão. 10. Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os procedimentos que estão – e dos que não estão – incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde. 11. No atendimento ao dever de informação, deve o consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar – com ou sem obstetrícia – e odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir. 12. Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo. 13. A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele, por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um

impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida. 14. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. 15. Hipótese em que a circunstância de o procedimento não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde, não é apta a autorizar a operadora a recusar o seu custeio, sobretudo considerando que a cirurgia prescrita para a recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no art. 10 da Lei 9.656/1998. 16. Ausente a indicação no acórdão recorrido de que a conduta da operadora, embora indevida, tenha agravado a situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela recorrida, ultrapassando o mero inadimplemento contratual, ou ainda de que a recorrida se encontrava em situação de urgente e flagrante necessidade de assistência à saúde, deve ser afastada a presunção do dano moral. 17. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Ademais, conforme prevê o art. 10 da Lei nº 9.656/98, existem critérios para que se possa alcançar a cobertura de exames e/ou tratamentos, os quais não estejam listados no rol de procedimentos e eventos da saúde suplementar, preconizando os seguintes termos:

§ 13.Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I -exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II -existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse sentido, a autora através dos documentos emitidos pelo médico acostados à exordial (evento 1), demonstra a importância do objeto da presente demanda, uma vez que integra o plano terapêutico que se destina a avaliar seu estado de saúde durante a gestação.

Frente ao caso em tela, cabe trazer à tona o direito fundamental à saúde - direito de 2º geração, insculpido na Constituição Federal de forma clara, nos termos das disposições dos artigos 6º e 196, o qual é uma responsabilidade de todos os entes estatais e devem fazer cumprir o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pertinente observar que a luz da legislação consumerista, o consumidor não pode ser prejudicado, devendo assim aplicar à interpretação de forma mais favorável no que diz respeito às cláusulas contratuais do plano de saúde, com expressão dos artigos:

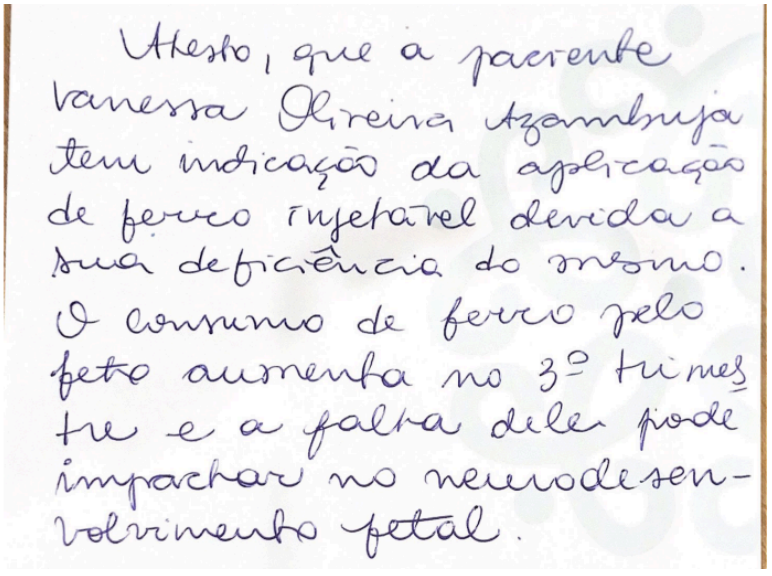
Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Nessa linha, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. RADIOTERAPIA. QUIMIOTERAPIA. REVISÃO DE CLAUSULA CONTATRUALK ABUSIVA. DANO MORA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.1.De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.2.Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, a orientação desta Corte é assente quando à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento.Precedentes.3Adravo interno desprovido (AgInt no AResp. 1198799/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Frente a todo o exposto deve ser confirmada a decisão liminar, a qual determinou o disponibilização do exame Iodo Urinário de 24h.

No que diz respeito ao fornecimento do medicamento Ferinject, também merece acolhido o pleito disposto na exordial. Cabe destacar que restou comprovado nos autos que a parte autora possuía indicação de uso de ferro injetável devido a deficiência do mesmo e que a falta dele podia impactar no neurodesenvolvimento do feto, nos seguintes termos (evento 1, ATESTMED10):


Atesto, que a paciente
Vanessa Oliveira Azambuja
tem indicação da aplicação
de ferro injetável devida a
sua deficiência do mesmo.
O consumo de ferro pelo
feto aumenta no 3º trimes
tre e a falta dele pode
impactar no neurodesen-
volvimento fetal.

A parte ré alega a inexistência de cobertura da medicação tendo em vista que seria de uso domiciliar. Ocorre que, a medicação ora requerida não se trata de medicamento de uso domiciliar, o que se denota pelo pedido da parte autora de que fornecimento do medicamento Ferinject fosse administrado no próprio serviço da ré, fato que a própria ré confirmou em evento 52, PET1:

> MM. Juiz de Direito
> Unimed Pelotas, já qualificada, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção à intimação dos eventos 44 e 49, dizer que a operadora deu efetivo cumprimento à ordem judicial, tendo a autora procurado o serviço de Pronto Atendimento para a aplicação do medicamento, no dia 22 de dezembro de 2023.
> Pede deferimento.

De igual forma, o atestado médico acostado à exordial (evento 1, DOC10) afirma que a suplementação de ferro a ser realizada seria feita por meio intravenoso. Assim, não sendo medicação de uso domiciliar, mas sim de uso ambulatorial, há o dever de cobertura contratual. Nesse sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMUNOGLOBULINA HUMANA. MEDICAMENTO DE APLICAÇÃO INTRAVENOSA, COM SUPERVISÃO, QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE USO DOMICILIAR. DEVER DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. De acordo com a interpretação do art. 10, VI, e do art. 12, I, 'c', II, 'g', da Lei n. 9.656/98, as operadoras de planos de saúde estão dispensadas de fornecer medicamentos de uso domiciliar, exceto antineoplásicos e medicamentos de uso em home care. Outrossim, presente o teor do art. 10, VI, e o disposto no art. 47 do CDC, segundo o qual o contrato deve sempre ser interpretado favoravelmente ao consumidor, a limitação de cobertura não abrange medicamentos de uso ambulatorial, hipótese em exame. Dever de cobertura contratual que determina o reembolso, pela ré, dos valores gastos pela autora com a medicação. 2. O dano moral, contudo, não se caracteriza, uma vez que a recusa da operadora está fundamentada, não se revelando arbitrária, nem de todo insustentável ou ofensiva às disposições legais/contratuais. O fato de a operadora ter sido condenada na obrigação de fazer, à luz da interpretação do julgador, não pode ser admitido como caracterizador de conduta ilícita para fins de responsabilidade civil. Responsabilidade da ré que se limita ao âmbito da execução do contrato. Precedentes do STJ. 3. Sentença confirmada. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (Apelação Cível, Nº 50097008220228210033, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 30-01-2024)*

Dessa forma, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente a demanda aforada por VANESSA OLIVEIRA DE AZAMBUJA em desfavor de UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, já qualificados, para confirmar a decisão liminar a qual determinou a imediata disponibilização do exame IODO URINÁRIO DE 24H e o fornecimento do medicamento FERINJECT, nos termos prescitos em evento 1, OUT7, a ser administrado/aplicado no próprio serviço da UNIMED PELOTAS durante o curso da gestação.

Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e da verba honorária devidas ao patrono da requerente, que arbitro em R$ 2.000,00, levando-se em conta o critério dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC.

Publique-se. Registre-se.

Com o trânsito em julgado e inertes os litigantes, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **PAULO IVAN ALVES MEDEIROS, Juiz de Direito**, em 8/2/2024, às 14:55:3, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10054132171v11** e o código CRC **67f26b7e**.